

Módulo 1 — SUS | Versão Consolidada

Concurso Médico IBAM | Praia Grande 001/2026 | Atualizado mai/2026

ões | Peso 2 | 40 pontos possíveis

ÍNDICE

- 1. GUIA ESTRATÉGICO — Distribuição de pontos e mapa de prioridades
- 2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS — Arts. 196 a 200 CF/88
- 3. LEI 8.080/1990 — Lei Orgânica da Saúde (profundidade máxima)
- 4. LEI 8.142/1990 — Controle Social e Financiamento
- 5. DECRETO 7.508/2011 — Regulamentação da Lei 8.080
- 6. LEI COMPLEMENTAR 141/2012 — Financiamento do SUS
- 7. PNAB 2017 — Política Nacional de Atenção Básica
- 8. FINANCIAMENTO DA APS — Do PAB ao modelo atual (Portaria 3.493/2024)
- 9. REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE — RAS e componentes
- 10. PROMOÇÃO DA SAÚDE — Carta de Ottawa, PNPS e Determinantes Sociais
- 11. TERRITORIALIZAÇÃO, REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA
- 12. VIGILÂNCIA EM SAÚDE — Epidemiológica, Sanitária, ANVISA
- 13. LNDC ATUALIZADA — Notificação compulsória (incluindo Portaria 11.211/2026)
- 14. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (e-SUS, RNDS, SUS Digital)
- 15. PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO E AUDITORIA
- 16. HUMANIZASUS — PNH
- 17. POLÍTICAS ESPECÍFICAS — Idoso, Criança, Mulher, Trabalhador, PSE
- 18. PNI — Programa Nacional de Imunização
- 19. MACETES, ESQUEMAS MENTAIS E LINHA DO TEMPO
- 20. PEGADINHAS CLÁSSICAS DO IBAM (27 identificadas)
- 21. QUESTÕES DE REVISÃO COMENTADAS (14 questões)

1. GUIA ESTRATÉGICO — DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS E MAPA

DE PRIORIDADES

Área SUS / Saúde Coletiva	Questões 20	Peso 2	Pontos 40	Prioridade MÁXIMA
Conhecimentos Específicos (MFC)	10	3	30	IIII MÁXIMA
Língua Portuguesa	10	1	10	IIII MÉDIA
				III

ESTRATÉGIA DE OURO

SUS = 40 pontos — maior fatia. Zerou SUS, não passa (exigido não zerar nenhuma matéria).

Meta: acertar 16-18 das 20 questões de SUS para folga na classificação.

Mínimo geral: 50% do total E não zerar qualquer área individualmente.

Foco absoluto: Lei 8.080 + Lei 8.142 + Decreto 7.508 + PNAB 2017 + LNDC atualizada.

Tema Princípios e diretrizes do SUS (Lei 8.080)Altíssima	Frequência IBAM	Profundidade Total — cada princípio individualmente
Controle social — Lei 8.142 (conselho x	conferência) Altíssima	Detalhada — composição, periodicidade
Decreto 7.508 — Região de Saúde, RENAME,	Alta RENASES	Detalhada — definições exatas

Tema Princípios e diretrizes do SUS (Lei 8.080)Altíssima	Frequência IBAM	Profundidade Total — cada princípio individualmente
PNAB 2017 — ESF, cobertura, equipe	Alta	Boa — foco em composição e cobertura
Financiamento — LC 141/2012, percentuais	Alta	Percentuais e o que não conta como saúde
Notificação compulsória — LNDC atualizada	Alta	Definições, prazos, inclusões recentes
Redes de Atenção à Saúde — RAS	Média-Alta	Estrutura geral e redes temáticas
Promoção da Saúde — Carta de Ottawa,	Média PNPS	Campos de ação e temas transversais
Determinantes Sociais da Saúde	Média	Lista completa do art. 3º Lei 8.080
HumanizaSUS — PNH	Média	Princípios e dispositivos
Sistemas de Informação (SINAN, SIM, SINASC)	Média	Reconhecimento e função de cada um
Políticas específicas (Idoso, Criança, Mulher)	Média	Leis e conceitos-chave
ANVISA — vigilância sanitária	Baixa-Média	Natureza jurídica e distinção de competências

2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS — Arts. 196 a 200 CF/88

Art. 196 — Redação exata (MEMORIZE)

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Palavras-chave: DIREITO DE TODOS | DEVER DO ESTADO | POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS | ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO | PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO

I PEGADINHAS — Art. 196

"Dever do Estado" ≠ "dever da União". Estado = todos os entes federativos.

"Direito de todos" inclui estrangeiros. A prova escreve "direito do cidadão brasileiro" → ERRADO.

"Universal e igualitário" é substituído por "seletivo" na pegadinha → ERRADO.

Art. 197 — Relevância Pública:

As ações e serviços de saúde são de **relevância pública**. A execução pode ser feita diretamente ou por terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198 — O SUS:

Integra uma **rede regionalizada e hierarquizada**. Organizado segundo 3 diretrizes:

- I — Descentralização com direção única em cada esfera
- II — Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
- III — Participação da comunidade

I PEGADINHAS — Art. 198

As 3 diretrizes do art. 198 são da CF — NÃO são os princípios do SUS (que vêm da Lei 8.080).

"Rede regionalizada e hierarquizada" é a caracterização do SUS, não a diretriz.

"Integralidade" aparece no inciso II como "atendimento integral" — mas a nomenclatura formal é da Lei 8.080.

Art. 199 — Iniciativa privada:

Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Instituições privadas participam do SUS em **caráter complementar**. É vedada destinação de recursos públicos para instituições privadas com fins lucrativos. É vedada participação de capitais estrangeiros, **salvo nos casos previstos em lei**.

Inciso I	Competência Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde
II	Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como de saúde do trabalhador
Inciso III	Competência Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde
IV	Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico
V	Incrementar em sua área o desenvolvimento científico e tecnológico
VI	Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional
VII	Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias psicoativas, tóxicas
VIII	Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho

I MACETE — Art. 200 (mnemônico)

“Con. Vis. Or. San. Cien. Ali. Psi. Meio”
CONtrole de procedimentos | Vlgilância sanitária+epidemiológica+trabalhador | ORdenação de RH |
SANEamento | CIENCIA | ALimentos | PSicoativos/tóxicos | MEIO ambiente

3. LEI 8.080/1990 — LEI ORGÂNICA DA SAÚDE

(PROFUNDIDADE MÁXIMA)

3.1 Objetivo e Fatores Determinantes e Condicionantes da Saúde (Art. 3º):

A Lei 8.080 regula as ações e serviços de saúde em todo território nacional. O art. 3º lista os **fatores determinantes e condicionantes da saúde** — lista cobrada direto na prova:

Art. 3º — Lista COMPLETA dos Determinantes (MEMORIZE)

Alimentação | Moradia | Saneamento básico | Meio ambiente | Trabalho | Renda
Educação | Atividade física | Transporte | Lazer | Acesso a bens e serviços essenciais
MACETE: "A.M.S.M.T.R. | E.A.T.L.A" — são 11 itens. A prova retira um ou acrescenta um falso.

3.2 Princípios vs Diretrizes — Diferença Fatal para Prova:

I PEGADINHA FATAL — Princípios vs Diretrizes

PRINCÍPIOS = valores filosóficos do SUS (universalidade, integralidade, equidade) → respondem "PARA QUÊ"
DIRETRIZES = formas de organização (descentralização, regionalização, hierarquização) → respondem "COMO"
CF/88 art. 198 = 3 diretrizes. Lei 8.080 art. 7º = lista ampla de princípios E diretrizes.

A prova mistura os dois grupos para você errar. Saiba a origem de cada um.

Princípio Universalidade	Conceito Essencial Acesso garantido a toda a população, sem distinção	Como Cai na Prova Trocam — incluindo por "seletividade" estrangeiros ou "prioridade a residentes"
Integralidade	Conjunto articulado de ações: promoção + proteção	Confundem + recuperação. com "integração" Abordagem ou integral listam apenas do ser humano ações
Equidade	Tratar desigualmente os desiguais — priorizar quem	Confundem mais precisa com "igualdade" para reduzir (que iniquidades é dar tudo igual). São

I MACETE — U.I.E. (Doutrinários)

U = Universalidade: para TODOS, sem distinção.

I = Integralidade: atenção COMPLETA — promoção + proteção + recuperação.

E = Equidade: MAIS para quem precisa mais. NÃO é igualdade.

Dica: Equidade ≠ Igualdade. Igualdade trata todos igual. Equidade trata diferente para ser justo.

Princípio/Diretriz Descentralização	Conceito Redistribuição de poder/responsabilidades entre esferas. Direção única em cada esfera.
Regionalização	Organização por regiões geográficas — Regiões de Saúde (Decreto 7.508)
Hierarquização	Organização por níveis de complexidade crescente (primário → secundário → terciário)

Princípio/Diretriz Participação social	Conceito Comunidade participa do planejamento e controle — Conselhos e Conferências de Saúde
Resolutividade	Capacidade de identificar e resolver o problema no ponto de atenção adequado
Conjugação de recursos	Integração de recursos federal, estadual e municipal para maior eficiência
Direito à informação	Paciente tem direito a informações sobre sua saúde e tratamento

Esfera UNIÃO	Órgão Gestor Ministério da Saúde	Competências-Chave Normatizar em âmbito nacional; coordenar redes de alta complexidade; elaborar
ESTADOS	Secretaria Estadual de SaúdeNormas	complementares; apoio técnico e financeiro a municípios; supletivamente
MUNICÍPIOS	Secretaria Municipal de SaúdePlanejar,	organizar, controlar e avaliar ações e serviços; GERIR E EXECUTAR

I PEGADINHAS — Competências

"Gerir e executar" os serviços = competência do MUNICÍPIO. A prova coloca como da União.

"Supletivamente complementar ações municipais" = competência do ESTADO. Não da União.

Vigilância em portos, aeroportos e fronteiras = UNIÃO. Municípios apenas "colaboram".

"Normatizar em âmbito nacional" = UNIÃO. Estados fazem normas COMPLEMENTARES.

4. LEI 8.142/1990 — CONTROLE SOCIAL E FINANCIAMENTO

Aspecto	Caráter	CONSELHO DE SAÚDE DELIBERATIVO e fiscalizador — toma decisões	CONFERÊNCIA DE SAÚDE AVALIATIVO com força e de propositivo ato administrativo — formula diretrizes, NÃO delibera
Periodicidade		PERMANENTE — funciona continuamente	A cada 4 ANOS (ou extraordinariamente, quando convocada)
Composição		50% usuários 25% trabalhadores de saúde	Representação 25% gestores e ampliada prestadores — diversidade da sociedade civil
Presidência		Eleita pelos próprios membros do Conselho	(NÃO Definida é o no Secretário regulamento de Saúde) da Conferência
Resultado		Resoluções (atos com força deliberativa) —	aprovadas Relatório Final por maioria — orienta simples a política de saúde (não tem força
Âmbito		Nacional (CNS), Estadual (CES), Municipal	(CMS) Nacional, Estadual, Municipal

I PEGADINHAS CLÁSSICAS — Lei 8.142

Conselho = "deliberativo" (não consultivo). A prova troca → ERRADO.
Conferência = a cada 4 anos (não 2 anos, não anual). A prova troca → ERRADO.
Composição = 50-25-25. A prova inverte os percentuais → ERRADO.
Presidente do Conselho é ELEITO pelos membros — não é o Secretário de Saúde → ERRADO.
Conferência é "propositiva" — NÃO delibera. A prova diz que a Conferência delibera → ERRADO.

Condições para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde:

4 condições para Municípios e Estados (Lei 8.142)

1. Fundo de Saúde constituído
 2. Conselho de Saúde em funcionamento
 3. Plano de Saúde aprovado pelo Conselho de Saúde
 4. Relatório de Gestão aprovado pelo Conselho de Saúde
- EXTRA para ESTADOS: também exige PCCS (Plano de Carreira, Cargos e Salários). Municípios NÃO precisam do PCCS.
MACETE: "FCPR" — Fundo, Conselho, Plano, Relatório.

5. DECRETO 7.508/2011 — REGULAMENTAÇÃO DA LEI 8.080

5.1 Região de Saúde — Definição Legal:

Definição exata — Decreto 7.508, art. 2º, I

"Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde."

Palavras-chave: ESPAÇO GEOGRÁFICO CONTÍNUO | MUNICÍPIOS LIMÍTROFES | IDENTIDADES COMPARTILHADAS | INTEGRAR ORGANIZAÇÃO/PLANEJAMENTO/EXECUÇÃO

Composição mínima obrigatória de toda Região de Saúde:

- Atenção primária
- Urgência e emergência
- Atenção psicossocial

- Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
- Vigilância em saúde

I PEGADINHAS — Região de Saúde

A Região de Saúde é instituída pelo ESTADO (em articulação com municípios). A prova diz "pela União"
→ ERRADO.

Municípios PODEM ser de estados diferentes — região pode ser interestadual.

"Municípios limítrofes" = com fronteira em comum. Não pode ser qualquer agrupamento.

Sigla RENAME	Nome Completo Relação Nacional de Medicamentos	O que é Essenciais Lista de medicamentos disponíveis pelo SUS.	Quem atualiza Ministério Base para da assistência Saúde — a farmacêutica. cada
RENASES	Relação Nacional de Ações e Serviços	Lista de Saúde de todas as ações e serviços que o SUS	Ministério oferece ao da usuário Saúde — em a todos cada

5.3 Portas de Entrada do SUS (art. 9º):

4 Portas de Entrada do SUS — MEMORIZE

1. Atenção Primária à Saúde
2. Urgência e Emergência
3. Atenção Psicossocial
4. Serviços Especiais de Acesso Aberto (ex.: centros de especialidades odontológicas, referência IST/AIDS)

ATENÇÃO: Ambulatório Especializado NÃO é porta de entrada — é acesso por REFERÊNCIA.

5.4 COAP — Contrato Organizativo de Ação Pública:

Acordo de colaboração entre entes federativos para organizar a rede regionalizada. Define responsabilidades, indicadores, metas e obrigações de financiamento entre os entes.

6. LEI COMPLEMENTAR 141/2012 — FINANCIAMENTO DO SUS

Esfera UNIÃO	Base de Cálculo Receita Corrente Líquida (RCL) — com correção pelo IPCA a partir	% Mínimo 15% da EC da 95/2016 RCL
ESTADOS e DF	Receita de impostos próprios + transferências constitucionais estaduais	12%
MUNICÍPIOS	Receita de impostos próprios + transferências constitucionais municipais	15%

I MACETE — Percentuais

ESTADO = 12% (o menor). MUNICÍPIO e UNIÃO = 15% (iguais).

Mnemônico: "Estado é menos exigente: 12. Município e União: 15."

EC 95/2016 (Teto dos Gastos): congelou o piso federal por 20 anos com correção pelo IPCA — tema atual.

6.2 O que NÃO conta como despesa em saúde (LC 141):

- Pagamento de aposentadorias e pensões (mesmo de servidores da área de saúde)
- Merenda escolar
- Saneamento básico (salvo quando vinculado à vigilância epidemiológica)
- Limpeza urbana e remoção de resíduos sólidos
- Preservação e correção do meio ambiente
- Ações de assistência social (salvo expressamente autorizadas)

- Obras de infraestrutura, ainda que com reflexos sobre a saúde
- Pagamento de pessoal inativo (aposentados e pensionistas)

I PEGADINHAS — LC 141

SANEAMENTO BÁSICO não conta como saúde! Mesmo que beneficie a saúde. Exceção: ações de vigilância epidemiológica associadas.

Aposentadorias e pensões de servidores da saúde NÃO contam — mesmo que sejam ex-médicos ou ex-enfermeiros.

Merenda escolar NÃO é despesa em saúde, mesmo beneficiando crianças.

7. PNAB 2017 — POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA

(Portaria 2.436/2017)

Definição de Atenção Básica — PNAB 2017

"Conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido."

É a PORTA DE ENTRADA PREFERENCIAL do SUS e o CENTRO DE COMUNICAÇÃO da Rede de Atenção à Saúde.

Profissional Médico	Quantidade 1	Detalhes Preferencialmente MFC; pode ser clínico geral com formação em APS
Enfermeiro	1	Formação adequada para AB
Técnico/Auxiliar de Enfermagem	1 a 2	Mínimo 1 por equipe
Agente Comunitário de Saúde (ACS)	Até 12	1 por microárea; cada ACS: até 750 pessoas ou 250 famílias
Agente de Combate a Endemias	(ACE) Quando necessárioIntegrado	à equipe conforme necessidade epidemiológica

Cobertura populacional Mínimo (áreas de alta vulnerabilidade)	Valor 2.000 pessoas
Recomendado	3.000 pessoas
MÁXIMO	4.000 pessoas
ACS — máximo por agente	750 pessoas OU 250 famílias

I PEGADINHAS — ESF

Máximo = 4.000. A prova diz "3.000 é o máximo" → ERRADO. 3.000 é o RECOMENDADO.

ACS: até 750 pessoas OU 250 famílias. A prova coloca 500 famílias → ERRADO.

Para ribeirinhos/fluviais: pode ter até 8 ACS com produção de até 3.450 pessoas.

Modalidade Modalidade I	Composição 1 cirurgião-dentista + 1 auxiliar em saúde bucal (ASB)	
Modalidade II	1 cirurgião-dentista + 1 ASB + 1 técnico em saúde bucal (TSB)	
Aspecto Status	NASF-AB (extinto) EXTINTO como modalidade de custeio	eMulti (vigente — Portaria 635/2023) federal Modelo (2020/2022) VIGENTE de apoio multiprofissional
Aspecto Portaria base		

	NASF-AB (extinto) Portaria 2.488/2011 e variações	eMulti (vigente — Portaria 635/2023) Portaria 635/2023
Composição	Multiprofissional variada	Mínimo 3 profissionais de categorias diferentes
Função	Apoio matricial às equipes de AB	Cuidado compartilhado e matriciamento — mesma lógica
Financiamento	Era por credenciamento	Incentivo federal próprio por equipe

I ATENÇÃO — NASF x eMulti

O NASF-AB foi EXTINTO como modalidade de custeio federal. Não existe mais como "NASF" no modelo de financiamento.

A eMulti (Portaria 635/2023) é o modelo atual. Mesma lógica de apoio matricial, nova regulamentação.

O edital cita a PNAB 2017 (que ainda menciona NASF no texto). Conheça os dois modelos — o histórico e o atual.

Se a questão perguntar o modelo VIGENTE de apoio multiprofissional: eMulti.

8. FINANCIAMENTO DA APS — DO PAB AO MODELO ATUAL

(Portaria 3.493/2024)

Período Até 2019	Modelo PAB Fixo (per capita) + PAB Variável (por adesão a programas:	Referência Lógica ESF, de NASF, estrutura etc.) — equipes credenciadas
2019–2024	Previne Brasil — capitação ponderada + pagamento por desempenho	Portaria 2.979/2019 + ações estratégicas — lógica de resultados e
A partir de 2024	Novo modelo de cofinanciamento federal com 6 componentesPortaria	3.493/2024 — substitui o Previne Brasil
2023	eMulti — novo modelo de apoio multiprofissional	Portaria 635/2023 — substitui o NASF como modalidade

Componente 1. Per capita de base populacionalValor	Descrição Resumida fixo por habitante para todos os municípios (R\$ 5,95/hab/ano em 2025). Base regular e previsível.
2. Por equipe credenciada (fixo)	Valor fixo por equipe de ESF ou eAP credenciada. Incentiva manutenção de equipes.
3. Vínculo e acompanhamento territorial	Baseado no cadastro real + potencial de cadastro. Incentiva busca ativa e adscrição de clientela.
4. Qualidade e boas práticas	Pagamento por desempenho em 15 indicadores de qualidade (a partir de 2025). Induz melhoria
5. Incentivos estratégicos	Ações específicas: Saúde na Escola, Saúde Bucal, Consultório na Rua, etc.
6. Compensação financeira	Para municípios com redução de repasse em relação ao modelo anterior. Garante transição sem

I PEGADINHAS — Financiamento APS

PREVINE BRASIL foi substituído pela Portaria 3.493/2024. Se a prova citar o Previne como modelo atual → questione o contexto.

PAB (Piso da Atenção Básica) era o modelo anterior ao Previne. Não é o modelo atual.

O novo modelo NÃO elimina o pagamento por desempenho — é o componente 4 (qualidade).

NASF foi extinto como modalidade de custeio. eMulti (Portaria 635/2023) é o modelo atual.

9. REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE — RAS

Rede Rede Cegonha	Portaria Base Portaria 1.459/2011	Foco Principal Saúde materno-infantil — pré-natal, parto, puerpério, criança até 24
Rede de Urgências (RUE)	Portaria 1.600/2011	SAMU (192), UPA 24h, hospitais — organização do atendimento de
RAPS	Portaria 3.088/2011	Saúde mental, álcool e outras drogas — CAPS como nó central
Rede Doenças Crônicas (RADC)	Portaria 252/2013	Hipertensão, diabetes, obesidade, doenças respiratórias crônicas
Rede de Cuidados à Pessoa com	Portaria Deficiência 793/2012	Reabilitação — CER (Centros Especializados em Reabilitação)

Componente RAPS Atenção Básica	Serviços UBS, ESF, Consultório na Rua, eMulti
Atenção Psicossocial Especializada	CAPS I, II, III, CAPSi, CAPSad, CAPSad III
Urgência e Emergência	SAMU, UPA, pronto-socorro
Atenção Residencial Transitória	Comunidade Terapêutica, Unidade de Acolhimento
Atenção Hospitalar	Leitos em Hospital Geral
Desinstitucionalização	Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Programa de Volta para Casa
Reabilitação Psicossocial	Centros de convivência, cooperativas, geração de trabalho e renda

CAPS — Tipos, Porte e Funcionamento

CAPS I: 20.000–70.000 hab. | CAPS II: 70.000–200.000 hab.

CAPS III: >200.000 hab. — funciona 24h, 7 dias/semana, tem leitos de observação.

CAPSi: infância/adolescência — municípios >150.000 hab.

CAPSad: álcool e drogas — >70.000 hab. | CAPSad III: 24h — >200.000 hab.

10. PROMOÇÃO DA SAÚDE — CARTA DE OTTAWA, PNPS E

DETERMINANTES SOCIAIS

10.1 Carta de Ottawa (1986):

1ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde, Ottawa, Canadá, 1986. Documento fundador do movimento moderno de promoção da saúde. Define promoção como **"o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde"**.

5 Campos de Ação da Carta de Ottawa (cobrados em prova):

Campo de Ação 1. Elaboração de políticas públicas saudáveis	Descrição Saúde em todas as políticas — todos os setores são responsáveis, não só saúde
2. Criação de ambientes favoráveis	Ambiente físico, social e econômico que proteja e promova a saúde
3. Reforço da ação comunitária	Participação ativa — comunidade controla e define sua saúde
4. Desenvolvimento de habilidades	personais Educação em saúde — capacitar para escolhas saudáveis e autocuidado
5. Reorientação dos serviços de saúde	Serviços

Campo de Ação 1. Elaboração de políticas públicas saudáveis	Descrição Saúde em todas as políticas — todos os setores são responsáveis, não só saúde
	além da cura — orientados para prevenção e promoção, centrados no usuário

I PEGADINHAS — Carta de Ottawa

São EXATAMENTE 5 campos de ação. A prova inclui um 6º falso (ex.: "ampliação de leitos hospitalares")

→ ERRADO.

Carta de Ottawa é de 1986 — documento INTERNACIONAL. PNPS é documento NACIONAL (2006, rev. 2014/2018).

Promoção da Saúde ≠ Prevenção de doenças. Promoção = ampla, sobre condições de vida. Prevenção = evitar doença específica.

10.2 PNPS — Política Nacional de Promoção da Saúde:

Instituída em 2006 (Portaria 687/2006), revisada em 2014 (Portaria 2.446/2014) e consolidada na Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28/09/2017 (publicada como PNPS 2018). É uma **política transversal** — não é um programa, atravessa toda a RAS.

6 Temas Transversais da PNPS (cobrados em prova):

Tema Transversal 1. Determinantes Sociais da Saúde, equidade	Descrição Resumida Abordar e diversidade as causas das causas — enfrentar desigualdades que geram iniquidades
2. Desenvolvimento sustentável	Integrar saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico de longo prazo
3. Produção de saúde e cuidado	Incorporar em redes que favoreçam práticas de cuidado integrado
4. Ambientes e territórios saudáveis	Intervir no espaço físico, social e relacional onde as pessoas vivem
5. Vida no trabalho	Saúde nos ambientes de trabalho — promoção e prevenção
6. Cultura de paz e direitos humanos	Reduzir violência, garantir direitos, cidadania e cultura de paz

I MACETE — Temas Transversais PNPS

"D.D.P.A.V.C." — Determinantes | Desenvolvimento | Produção de saúde | Ambientes | Vida no trabalho | Cultura de paz

Prova inclui falso como "assistência hospitalar de alta complexidade" → ERRADO (é promoção, não cura).

PNPS é TRANSVERSAL — atravessa todos os setores e programas do SUS.

10.3 Determinantes Sociais da Saúde (DSS):

São condições sociais, econômicas, culturais, étnico-raciais, psicológicas e comportamentais que influenciam a saúde. Conceito fundamental na saúde coletiva e diretamente cobrado.

Modelo de Dahlgren e Whitehead — "Arco-íris dos DSS"

Camada 1 (centro): Fatores biológicos individuais — idade, sexo, carga genética. NÃO modificáveis.

Camada 2: Comportamentos e estilos de vida individuais.

Camada 3: Redes sociais e comunitárias — apoio social, coesão.

Camada 4: Condições de vida e trabalho — moradia, saneamento, emprego, educação, alimentação.

Camada 5 (externo): Condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais.

Quanto mais externo = mais estrutural e difícil de modificar, mas maior impacto coletivo.

I PEGADINHAS — DSS

"Iniquidades em saúde" = desigualdades INJUSTAS e EVITÁVEIS. Diferente de desigualdades naturais.

Art. 3º Lei 8.080: lista completa dos determinantes. A prova retira "atividade física", "lazer" ou "transporte"

— fique atento.

"Determinantes Sociais" ≠ apenas pobreza. Incluem raça, gênero, educação, moradia, acesso a serviços.

11. TERRITORIALIZAÇÃO, REFERÊNCIA E

CONTRARREFERÊNCIA

Unidade Territorial Área de abrangência	Definição Conjunto de microáreas cobertas por uma UBS/ESF	Responsável Equipe de Saúde da Família
Microárea	Menor unidade — espaço geográfico de cada ACS	Agente Comunitário de Saúde (ACS)
Adscrição de clientela	Vínculo de responsabilidade entre equipe e população do	território Toda a Equipe ESF

Adscrição de clientela: cada família é vinculada a uma equipe de referência. A adscrição organiza responsabilidade sanitária, mas NÃO impede o usuário de buscar atendimento em outros pontos da rede.

Conceito REFERÊNCIA	Sentido APS → Especialidade / Hospital	Descrição (subir Encaminhamento na complexidade) para nível de maior densidade tecnológica. A APS
CONTRARREFERÊNCIA	Especialidade / Hospital → APS	(retornar) Retorno do usuário ao serviço de origem com informações sobre o atendimento

I PEGADINHAS — Referência e Contrarreferência

Referência = de MENOR para MAIOR complexidade. A prova inverte → ERRADO.

Contrarreferência ≠ alta hospitalar. É o retorno QUALIFICADO para a APS com informações clínicas.

Ausência de contrarreferência é um dos maiores problemas de fragmentação do SUS — tema conceitual cobrado.

Regulação do acesso = função organizadora do fluxo — papel da gestão (Complexos Reguladores, SISREG).

12. VIGILÂNCIA EM SAÚDE — EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E

ANVISA

Tipo Vigilância Epidemiológica	Objeto Doenças e agravos à saúde na população	Exemplos de Ação Notificação, — monitoramento investigação e controle de surtos, controle de epidemias
Vigilância Sanitária	Riscos sanitários — produtos, serviços,	ambientes Fiscalização de interesse de alimentos, à saúde medicamentos, serviços de saúde,
Vigilância Ambiental	Fatores do meio ambiente que afetam a	saúde Controle de vetores (dengue, malária), qualidade da água
Saúde do Trabalhador	Processos de trabalho e saúde do trabalhador	CEREST, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais,
Vigilância da Situação de Saúde	Análise de indicadores — situação de saúde	Análise da população de mortalidade, morbidade, indicadores epidemiológicos

Aspecto Lei de criação	Detalhe Lei 9.782/1999
Natureza jurídica	Autarquia federal de regime especial (agência reguladora)

Aspecto Lei de criação	Detalhe Lei 9.782/1999
Independência	Diretores com mandato fixo — independência técnica e financeira
Competência	Regulação federal de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos de saúde, serviços de interesse
Relação com SUS	Vinculada ao MS. VISA estaduais e municipais complementam a atuação no território
Poder de polícia	Interdição, apreensão, cancelamento de registros, multas

I PEGADINHAS — ANVISA e VISA

ANVISA é autarquia com autonomia — NÃO é departamento ou secretaria do MS.

VISA ≠ Vigilância Epidemiológica: VISA regula produtos/serviços. VE monitora doenças na população.

Distinção prática: VISA fiscaliza a farmácia; VE monitora surto de intoxicação alimentar naquela farmácia.

Lei de criação da ANVISA: 9.782/1999. A prova pode cobrar o número da lei.

Aspecto CEREST	Detalhe Centro de Referência em Saúde do Trabalhador — apoio técnico especializado para a rede SUS
RENAST	Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador — contexto dos CERESTs
CAT	Comunicação de Acidente de Trabalho — emitida pelo empregador (1 dia útil), médico ou trabalhador
Acidente de trabalho	Todo acidente que ocorra pelo exercício do trabalho que cause lesão corporal, perturbação funcional
Doenças profissional vs do trabalho	Profissional: inerente ao tipo de trabalho. Do trabalho: potencialmente causada pelas condições de
SINAN — notificação	Qualquer acidente de trabalho é de notificação compulsória (Portaria 217/2023)

13. LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA —

ATUALIZADA ATÉ MAIO/2026

ATUALIZAÇÕES CRÍTICAS RECENTES — COBRADAS EM PROVA

Portaria 11.211/2026 (13/05/2026): inclusão de Caxumba e Febre do Oropouche; retirada da Covid-19 como item isolado; ESAVI como novo termo para eventos adversos vacinais.

Portaria 10.175/2026 (jan/2026): anomalias congênitas incluídas na LNDC.

Portaria 3.148/2024: HTLV incluído na LNDC.

Portaria 217/2023: qualquer acidente de trabalho passa a ser notificável (antes: apenas grave/fatal).

Tipo Notificação Imediata	Prazo Até 24 horas — pelo meio mais	Exemplos Varíola, rápido poliomielite, disponível cólera, febre hemorrágica viral, influenza humana
Notificação Semanal	Até o 1º dia útil da semana seguinte	Dengue (em áreas endêmicas), leishmaniose, esquistossomose, Febre
Notificação Negativa	Obrigatória mesmo sem casosComprova	vigilância ativa — semana epidemiológica sem registro de
Portaria Portaria 11.211/2026	Mudança INCLUSÃO: Parotidite (Caxumba) — notificação imediata a MS,	Relevância para prova Alta SES — e recente, SMS pode cair
Portaria 11.211/2026		

Portaria Portaria 11.211/2026	Mudança INCLUSÃO: Parotidite (Caxumba) — notificação imediata a MS,	Relevância para prova Alta SES — e recente, SMS pode cair
	INCLUSÃO: Febre do Oropouche — semanal para casos; imediata	Alta para — doença gestantes, emergente óbitos, em anomalias foco
Portaria 11.211/2026	Covid-19 sai como item isolado. Vira "Síndrome Gripal por Covid-19	Média confirmada" — mudança de nomenclatura
Portaria 11.211/2026	ESAVI substitui "Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação"	Alta — nova terminologia oficial
Portaria 11.211/2026	Difteria: notificação imediata ao Ministério da Saúde (mudança	de Média periodicidade)
Portaria 10.175/2026	INCLUSÃO: Anomalias congênitas (jan/2026)	Alta — muito recente
Portaria 3.148/2024	INCLUSÃO: HTLV, HTLV em gestante/puérpera e criança exposta	Média
Portaria 217/2023	Qualquer acidente de trabalho notificável (antes: só grave/fatal/criança)	Alta — mudança ampla

Febre do Oropouche — O que é:

Arbovirose causada pelo vírus Oropouche (OROV), transmitido pelo mosquito Culicoides paraensis (maruim/mosquito-pólvora).

Surtos em 2024/2025 no Brasil, principalmente na Amazônia. Casos graves em gestantes (óbitos fetais, microcefalia).

Por isso: notificação IMEDIATA para gestantes, óbitos, anomalias congênitas e óbitos fetais.

Casos confirmados sem complicações: notificação SEMANAL.

I PEGADINHAS — Notificação Compulsória

Notificação é dever de TODOS — não apenas de médicos. Qualquer profissional de saúde pode e deve notificar.

Notificação Negativa NÃO significa ausência de doença — significa que a vigilância está ativa e verificou.

Covid-19 não foi REMOVIDA da lista — mudou de nome (Síndrome Gripal por Covid-19 confirmada).

SINAN = sistema onde se registram as notificações (não confundir com SIM, SINASC ou SIH).

Caxumba: antes NÃO era notificável. Agora é — com notificação IMEDIATA.

14. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE — e-SUS, RNDS E

SUS DIGITAL

Sistema Sistema de Informação de Agravos de Notificação	Sigla SINAN	Função Principal Registro das doenças de notificação compulsória — principal sistema
Sistema de Informação sobre Mortalidade	SIM	Registro de óbitos — base: Declaração de Óbito (DO)
Sistema de Informação sobre Nascidos VivosSINASC		Registro de nascimentos — base: Declaração de Nascido Vivo (DNV)
Sistema de Informação Hospitalar	SIH	Registro de internações — base: AIH (Autorização de Internação)
Sistema de Informação Ambulatorial	SIA	Produção ambulatorial — base: BPA (Boletim de Produção Ambulatorial)
Sistema de Informação da APS	SISAB / e-SUS	

Sistema Sistema de Informação de Agravos de Notificação	Sigla SINAN	Função Principal Registro das doenças de notificação compulsória — principal sistema
		Produção e indicadores da Atenção Básica — prontuário eletrônico
Sistema de Informação do PNI	SIPNI	Registro de doses vacinais e cobertura vacinal
Sist. de Informação sobre Orçamentos em Saúde	SIOPS	Gastos e financiamento em saúde pelos entes
Rede Nacional de Dados em Saúde	RNDS	Plataforma de interoperabilidade do SUS — Decreto 12.560/2025

RNDS e SUS Digital (Decreto 12.560/2025):

A RNDS foi oficializada como plataforma de interoperabilidade do SUS pelo Decreto 12.560/2025 (julho/2025). Integra dados de saúde de todos os pontos da RAS — permitindo que o histórico do paciente acompanhe sua trajetória no sistema.

Plataforma Meu SUS Digital (app)	Público-alvo Cidadão / Usuário	Função Acesso ao cartão SUS digital, histórico vacinal, exames, receitas
SUS Digital Profissional	Profissionais de saúde	Acesso ao histórico clínico do paciente durante o atendimento
SUS Digital Gestor	Gestores	Monitoramento de indicadores e gestão
e-SUS APS (Prontuário Eletrônico)Equipes	da APS	Registro do cuidado na Atenção Básica — envia dados ao SISAB

I MACETE — Sistemas de Informação

SIM = óbitos (MORTalidade). SINASC = nascimentos (NASCimentos). SINAN = Notificação.
 SIH = Hospitalar (internações). SIA = Ambulatorial (consultas, procedimentos ambulatoriais).
 SIPNI = vacinação. SIOPS = orçamentos e gastos em saúde.
 RNDS = plataforma que INTEGRA todos os sistemas — é a "internet" dos dados de saúde do SUS.

15. PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO E AUDITORIA NO SUS

Instrumento Plano Nacional de Saúde (PNS)	Âmbito Federal	Periodicidade 4 anos	Aprovação CNS (Conselho Nacional de Saúde)
Plano Estadual de Saúde (PES)	Estadual	4 anos	CES
Plano Municipal de Saúde (PMS)	Municipal	4 anos	CMS
Programação Anual de Saúde (PAS)	Todas as esferas	Anual	Conselho correspondente
Relatório Anual de Gestão (RAG)	Todas as esferas	Anual (prestação	de Conselho contas) correspondente

Função REGULAÇÃO	Conceito Conjunto de ações que intermedia o usuário e o serviço, ordenando o acesso às ações e serviços
CONTROLE	Acompanhamento das atividades dos prestadores — verifica cumprimento dos contratos
AVALIAÇÃO	Análise sistemática para verificar se os objetivos e metas foram alcançados

Função REGULAÇÃO	Conceito Conjunto de ações que intermedia o usuário e o serviço, ordenando o acesso às ações e serviços
AUDITORIA	Revisão de registros, processos e contas — busca inconsistências e fraudes — competência do DENASUS

16. HUMANIZASUS — POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO

(PNH)

Lançada em 2003. Política transversal — não é programa, atravessa todos os níveis e áreas do SUS. Propõe mudanças nos modos de gerir e cuidar.

Dispositivo/Ferramenta PNH Acolhimento	Definição e Aplicação Postura de escuta qualificada e responsabilização — em todos os pontos de atenção, em todos
Clínica Ampliada	Abordagem integral do sujeito — vai além da doença, olha o contexto, a subjetividade
Projeto Terapêutico Singular (PTS)	Conjunto de propostas de condutas terapêuticas multiprofissionais para o sujeito
Projeto de Saúde no Território (PST)	Intervenção coletiva articulada com outros setores — produção de saúde no território
Apoio Matricial	Suporte especializado a equipes de referência — compartilhamento de saberes
Equipe de Referência	Equipe responsável pelo cuidado longitudinal do usuário
Linha de Cuidado	Fluxo assistencial centrado nas necessidades do usuário — percurso no sistema
Colegiado Gestor	Gestão coletiva das unidades — participação de trabalhadores nas decisões
Visita Aberta e Direito ao Acompanhante	Garantia de acompanhante no hospital (reforçada pela Lei 11.108/2005)
Carta de Direitos dos Usuários	Participação e controle social no cuidado — ouvidoria

I PEGADINHAS — HumanizaSUS

PNH NÃO é programa — é POLÍTICA. Atravessa transversalmente todos os programas do SUS.

"Acolhimento" na PNH ≠ triagem. É postura de TODOS os trabalhadores em TODOS os momentos.

Clínica Ampliada ≠ clínica especializada. Ampliada olha o sujeito além da doença.

17. POLÍTICAS ESPECÍFICAS — IDOSO, CRIANÇA, MULHER,

TRABALHADOR E PSE

Aspecto Definição de idoso	Detalhe para Prova 60 anos ou mais
Gratuidade no transporte COLETIVO	65 urbano anos ou mais (art. 39)
Desconto 50% transporte INTERESTADUAL	60 anos ou mais (2 vagas gratuitas por ônibus)
Prioridade no atendimento	Bancos, repartições, serviços de saúde, transportes — 60 anos ou mais
PNSPI — Política Nacional de Saúde	Portaria da Pessoa 2.528/2006 Idosa — envelhecimento ativo e saudável — autonomia e independência

Aspecto Definição de idoso	Detalhe para Prova 60 anos ou mais
Abuso e violência contra idoso	Notificação compulsória — qualquer profissional de saúde pode e deve notificar

I PEGADINHA — Estatuto do Idoso

Idoso = 60 anos. Gratuidade no transporte COLETIVO = 65 anos. A prova confunde → leia com cuidado.

"Gratuidade para maiores de 60 anos no transporte" → ERRADO para ônibus urbano (é 65). CORRETO para desconto de 50% no interestadual.

Aspecto ECA — definição de criança	Detalhe 0 a 12 anos incompletos. Adolescente: 12 a 18 anos. Lei 8.069/1990.
PNAISC	Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança — Portaria 1.130/2015
Aleitamento materno exclusivo	Recomendado até 6 meses. Complementar até 2 anos ou mais (OMS/MS).
Teste do Pezinho	Triagem neonatal — recomendado: 3 a 5 dias de vida. Obrigatório.
Teste da Orelhinha	Triagem auditiva — obrigatória em hospitais com mais de 500 partos/ano
Teste do Olhinho	Reflexo vermelho — rastreamento de catarata e alterações oculares
Triagem cardíaca neonatal	Oximetria de pulso ao nascimento — cardiopatia congênita crítica
Caderneta de Saúde da Criança	Instrumento de registro e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento

Aspecto PHPN	Detalhe Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento — Portaria 569/2000
Mínimo de consultas de pré-natal (SUS)	6 consultas (1 no 1º trimestre, 2 no 2º, 3 no 3º)
Exames obrigatórios no pré-natal	Tipagem sanguínea/Rh, VDRL, hemograma, urina, glicemia, HIV, HBsAg, toxoplasmose, rubéola
Rede Cegonha	Portaria 1.459/2011 — humanização do pré-natal, parto e puerpério. Inclui Casa da Gestante
Direito ao acompanhante	Lei 11.108/2005 — garantia legal de 1 acompanhante no parto e puerpério
Início do pré-natal	Até 120 dias (4 meses) de gestação — critério do PHPN

I PEGADINHAS — Saúde da Mulher

Direito ao acompanhante no parto: Lei 11.108/2005 (lei específica). A prova cobra a base legal.

Mínimo de consultas de pré-natal no SUS = 6. Recomendação OMS atual = 8 ou mais consultas.

Rede Cegonha não é só maternidade — inclui pré-natal na UBS, vinculação à maternidade e visita puerperal domiciliar.

17.4 Programa Saúde na Escola (PSE):

Decreto 6.286/2007. Intersetorialidade entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Equipes ESF executam ações nas escolas públicas do território. É o exemplo clássico de **intersectorialidade** cobrado em prova.

Aspecto Base legal	Detalhe Decreto 6.286/2007
Objetivo	Contribuir para o desenvolvimento pleno dos estudantes da rede pública

Aspecto Base legal	Detalhe Decreto 6.286/2007
Intersetorialidade	MS + MEC — saúde e educação juntos
Executor	Equipes ESF responsáveis pelas escolas do território
Ações	Vacinação, saúde bucal, saúde ocular, saúde mental, prevenção de violência, alimentação saudável

18. PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI)

Aspecto Criação	Detalhe para Prova 1973 — um dos mais completos e antigos do mundo
Gestão	MS coordena. Estados e municípios: execução e distribuição
Calendários	Criança Adolescente Adulto/Idoso Gestante Indígena Trabalhadores de Saúde
SIPNI	Sistema de Informação do PNI — registra doses e monitora cobertura vacinal
Meta de cobertura	95% para a maioria das vacinas (OMS/MS) — queda = risco de ressurgimento de doenças
ESAVI	Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização — novo termo (Portaria 11.211/2026)
Rede de frio (cadeia de frio)	Armazenamento e transporte correto das vacinas — pré-requisito para eficácia
Vacinação compulsória	NÃO é compulsória no Brasil (não há obrigatoriedade com sanção penal). Mas pode-se exigir

I PEGADINHAS — PNI

Vacinação NÃO é compulsória no Brasil — ninguém pode ser vacinado à força. A prova diz "é obrigatória" → ERRADO.

SIPNI ≠ SINAN. SIPNI = vacinação. SINAN = doenças de notificação.

ESAVI = novo termo para eventos adversos vacinais. "Eventos adversos pós-vacinação" é terminologia desatualizada.

Queda de cobertura vacinal é risco para ressurgimento de doenças erradicadas — conceito cobrado.

19. MACETES, ESQUEMAS MENTAIS E LINHA DO TEMPO

HIERARQUIA DAS LEIS DO SUS:

- CF/88 (Arts. 196-200) → Base constitucional — TUDO começa aqui
- ↓
- Lei 8.080/1990 → Organização e funcionamento — princípios, competências
- ↓
- Lei 8.142/1990 → Controle social e transferência de recursos
- ↓
- Decreto 7.508/2011 → Regulamentação da 8.080 — RENAME, RENASES, Regiões, COAP
- ↓
- LC 141/2012 → Percentuais mínimos de financiamento em saúde
- ↓
- Portaria 2.436/2017 (PNAB) → Política Nacional de Atenção Básica
- ↓
- Portaria 3.992/2017 → Dois blocos de financiamento federal (custeio e investimento)
- ↓

Portaria 635/2023 (eMulti) → Modelo atual de apoio multiprofissional à APS

↓

Portaria 3.493/2024 → Novo modelo de cofinanciamento federal da APS (substitui Previne Brasil)

↓

Decreto 12.560/2025 → RNDS como plataforma oficial de interoperabilidade do SUS

↓

Portaria 11.211/2026 → Atualização da LNDC (Caxumba, Oropouche, ESAVI)

Ano 1973	Evento Criação do PNI	Importância Um dos mais antigos e completos do mundo
1986	Carta de Ottawa	Base internacional da promoção da saúde — 5 campos de ação
1988	CF/88 — Arts. 196-200	Fundamento constitucional do SUS
1990	Leis 8.080 e 8.142	Leis orgânicas — as mais cobradas em concurso
2000	Emenda Constitucional 29	Vinculação de recursos à saúde — origem da LC 141
2000	PHPN — Portaria 569	Humanização do pré-natal — 6 consultas mínimas
2003	HumanizaSUS — PNH	Política de humanização — dispositivos e princípios
2006	PNPS — Portaria 687	Política Nacional de Promoção da Saúde — 1ª versão
2007	PSE — Decreto 6.286	Saúde na Escola — intersetorialidade saúde+educação
2011	Decreto 7.508	RENAME, RENASES, Regiões de Saúde, COAP
2011	Portaria 3.088 — RAPS	Rede de Atenção Psicossocial — CAPS como nó central

Ano 2012	Evento LC 141	Importância Percentuais mínimos de financiamento — regulamenta EC 29
2014	PNPS revisada — Portaria 2.446	6 temas transversais consolidados
2017	PNAB — Portaria 2.436	Política Nacional de Atenção Básica vigente
2019	Previne Brasil — Portaria 2.979	Financiamento APS por capitação e desempenho (substituído em 2024)
2020/2022	Extinção do NASF como custeio	Mudança de paradigma no apoio matricial
2023	eMulti — Portaria 635	Novo modelo de apoio multiprofissional à APS
2023	Portaria 217/2023 — LNDC	Qualquer acidente de trabalho notificável
2024	Portaria 3.493/2024	Novo modelo de cofinanciamento APS — substitui Previne Brasil
2024	Portaria 3.148/2024 — LNDC	HTLV incluído na notificação compulsória
2025	Decreto 12.560/2025	RNDS como plataforma oficial do SUS Digital
Jan/2026	Portaria 10.175/2026	Anomalias congênitas na LNDC
Mai/2026	Portaria 11.211/2026	Caxumba e Oropouche na LNDC; ESAVI como novo termo

20. PEGADINHAS CLÁSSICAS DO IBAM — 27 IDENTIFICADAS

1. Universalidade vs. Seletividade

→ O SUS é UNIVERSAL — para todos. "Prioritariamente" ou "mediante comprovação de carência" → ERRADO.

2. Equidade ≠ Igualdade

→ Equidade = tratar desigualmente para ser justo. Igualdade = tratar todos igual. O SUS adota EQUIDADE. A prova troca.

3. Conselho = deliberativo / Conferência = propositiva

→ Conselho: PERMANENTE e DELIBERATIVO. Conferência: a cada 4 ANOS e AVALIATIVA/PROPOSITIVA. A prova inverte.

4. Composição do Conselho: 50-25-25

→ 50% usuários | 25% trabalhadores | 25% gestores+prestadores. A prova coloca 33-33-33 ou inverte.

5. Presidente do Conselho é eleito pelos membros

→ NÃO é o Secretário de Saúde! É eleito entre os membros do Conselho. A prova diz o contrário.

6. Direção única em cada esfera

→ O SUS tem UMA direção em cada esfera. Não é hierarquia entre esferas — município não é subordinado ao Estado.

7. Saneamento básico NÃO conta como saúde

→ LC 141 é clara. Mesmo que beneficie a saúde. Exceção: ações de vigilância epidemiológica vinculadas.

8. "Gerir e executar" = competência do Município

→ A prova coloca como da União. Gerir e executar os serviços públicos de saúde = MUNICÍPIO.

9. "Supletivamente complementar" = competência do Estado

→ Complementar ações municipais supletivamente = ESTADO, não da União.

10. Portas de entrada: APS, urgência, psicossocial e acesso aberto

→ Ambulatório especializado NÃO é porta de entrada — é acesso por referência.

11. ESF: máximo 4.000 pessoas / ACS: 750 pessoas

→ Recomendado: 3.000. Máximo: 4.000. ACS: até 750 pessoas ou 250 famílias. A prova troca os valores.

12. Art. 196: dever do ESTADO (não só da União)

→ Estado = todos os entes federativos. "Dever da União" ou "dever do município" são incompletos.

13. Iniciativa privada em caráter COMPLEMENTAR

→ Art. 199 CF: participação privada é complementar — não igualitária ao setor público.

14. Notificação: dever de TODOS, não só de médicos

→ Qualquer profissional de saúde pode e deve notificar. A prova restringe "apenas a médicos".

15. RENAME e RENASES: atualizadas a cada 2 anos

→ Ministério da Saúde atualiza as duas relações a cada 2 anos. A prova diz "anualmente" → ERRADO.

16. Promoção da Saúde ≠ Prevenção de Doenças

→ Promoção: ampla, sobre condições de vida. Prevenção: evitar doença específica. A prova mistura.

17. Carta de Ottawa: 1986 — documento INTERNACIONAL

→ PNPS é o documento nacional. Carta de Ottawa = base internacional de 1986. A prova atribui a carta ao MS.

18. Art. 3º Lei 8.080: 11 determinantes — lista COMPLETA

→ A prova omite "atividade física", "lazer" ou "transporte" — itens que estão na lista. Memorize todos.

19. Idoso = 60 anos / Gratuidade transporte = 65 anos

→ Estatuto: idoso = 60 anos. Gratuidade no transporte coletivo urbano = 65 anos. A prova confunde.

20. PSE: exemplo de INTERSETORIALIDADE saúde+educação

→ Decreto 6.286/2007. A prova pergunta "qual é o principal exemplo de intersetorialidade" → PSE.

21. NASF foi extinto / eMulti é o modelo atual

→ NASF-AB não existe mais como custeio federal. A prova pode cobrar o modelo atual → eMulti.

22. Previne Brasil foi substituído pela Portaria 3.493/2024

→ Se a prova citar Previne Brasil como modelo vigente em 2026 → desatualizado.

23. Caxumba é agora notificável com notificação IMEDIATA

→ Portaria 11.211/2026. Antes: não era notificável. A prova pode cobrar essa mudança recente.

24. Oropouche: notificação SEMANAL (casos) e IMEDIATA (gestantes/óbitos)

→ Depende do caso. Confirmados simples = semanal. Gestantes, óbitos, anomalias congênitas = imediata.

25. ESAVI = novo nome para eventos adversos vacinais

→ Substitui "eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação". Portaria 11.211/2026.

26. ANVISA = autarquia federal — não é secretaria ou departamento

→ Lei 9.782/1999. Tem diretores com mandato fixo e independência técnica.

27. Referência: APS → especialidade. Contrarreferência: especialidade → APS

→ A prova inverte os sentidos. Referência = subir. Contrarreferência = retornar à APS.

21. QUESTÕES DE REVISÃO COMENTADAS — ESTILO IBAM

(14 questões)

4 alternativas cada. Gabarito e comentário estratégico após cada questão.

Questão Q1: Conforme o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é:

- A) Direito do cidadão brasileiro e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
- B) Direito de todos e dever exclusivo da União, garantido mediante políticas de saúde pública.
- C) Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.
- D) Direito do cidadão e dever solidário da União, Estados e Municípios, garantido exclusivamente por políticas de saúde.

Gabarito: Alternativa C

A = "cidadão brasileiro" → ERRADO (é "todos", incluindo estrangeiros). B = "dever exclusivo da União" → ERRADO (é dever do Estado = todos os entes). D = "exclusivamente por políticas de saúde" → ERRADO (são políticas sociais E econômicas). C reproduz a redação correta do art. 196.

Questão Q2: Quanto à composição dos Conselhos de Saúde (Lei 8.142/1990), é correto afirmar que:

- A) Os usuários representam 25%, trabalhadores 25% e gestores/prestadores 50%.
- B) Os usuários representam 50%, trabalhadores de saúde 25% e gestores/prestadores 25%.
- C) A composição é paritária entre usuários e profissionais de saúde — 50% para cada grupo.
- D) A presidência é exercida pelo Secretário de Saúde da esfera correspondente.

Gabarito: Alternativa B

B = composição correta: 50-25-25. A = inverte a composição. C = ignora a distinção trabalhadores/gestores. D = ERRADO: presidente é eleito pelos membros do Conselho.

Questão Q3: O Decreto 7.508/2011 define Região de Saúde como:

- A) Espaço geográfico definido pelo Ministério da Saúde, com municípios de características epidemiológicas semelhantes.
- B) Conjunto de municípios do mesmo estado para prestação integrada de serviços de alta complexidade.
- C) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
- D) Área de abrangência de uma Secretaria Estadual de Saúde, definida para planejamento regional.

Gabarito: Alternativa C

C = redação quase literal do Decreto 7.508. A = define o Estado (não MS) e critério não é epidemiológico. B = pode ser interestadual e não é só para alta complexidade. D = não se restringe à área da SES.

Questão Q4: Conforme a LC 141/2012, qual despesa NÃO é considerada ação e serviço público de saúde?

- A) Ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
- B) Pagamento de aposentadorias de servidores da área de saúde.
- C) Assistência farmacêutica e atenção básica.
- D) Ações de saúde do trabalhador realizadas por equipes de saúde.

Gabarito: Alternativa B

LC 141 exclui expressamente pagamento de inativos e pensionistas — mesmo que sejam ex-servidores da saúde. A, C e D são despesas legítimas em saúde conforme a LC 141.

Questão Q5: Para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, os municípios devem atender, conforme Lei 8.142/1990:

- A) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde em funcionamento, Plano de Saúde e Relatório de Gestão aprovado pelo Conselho.
- B) Secretaria de Saúde estruturada, Plano de Saúde aprovado pelo Executivo, Fundo de Saúde e relatório de auditoria.
- C) Conselho de Saúde, Plano de Saúde aprovado pelo Poder Legislativo, Fundo de Saúde e equipe mínima.
- D) Fundo de Saúde, Conselho, Plano, Relatório de Gestão e Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).

Gabarito: Alternativa A

A = correto para MUNICÍPIOS. D = PCCS é condição adicional apenas para ESTADOS — municípios não precisam. B e C têm aprovação pelo Executivo e Legislativo, respectivamente → ERRADO (é pelo Conselho).

Questão Q6: A ESF é responsável por cobertura de:

- A) No mínimo 2.000 e no máximo 3.000 pessoas.
- B) No mínimo 2.000 e no máximo 4.000 pessoas, com recomendação de 3.000.
- C) No mínimo 3.000 e no máximo 5.000 pessoas.
- D) Exatamente 4.000 pessoas em todos os contextos.

Gabarito: Alternativa B

Mínimo: 2.000 (alta vulnerabilidade). Recomendado: 3.000. Máximo: 4.000. A confunde recomendado com máximo. C e D estão erradas.

Questão Q7: O princípio da equidade no SUS significa que:

- A) Todos recebem exatamente o mesmo tipo e quantidade de serviços.
- B) Os serviços são distribuídos igualmente entre municípios.
- C) As desigualdades são reconhecidas para priorizar quem mais necessita, reduzindo iniquidades.
- D) Os recursos são distribuídos de forma proporcional à população de cada município.

Gabarito: Alternativa C

Equidade ≠ igualdade. C descreve corretamente. A e B descrevem igualdade. D descreve critério proporcional — não é equidade.

Questão Q8: As portas de entrada do SUS, conforme Decreto 7.508/2011, são:

- A) Atenção primária, ambulatório especializado, urgência e atenção hospitalar.
- B) Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto.
- C) UBS, CAPS, hospitais gerais e pronto-socorros.
- D) Atenção básica, policlínicas, hospitais de média complexidade e serviços de urgência.

Gabarito: Alternativa B

Decreto 7.508, art. 9º: as 4 portas de entrada. A inclui "ambulatório especializado" (que é via referência). C e D misturam serviços com portas de forma incorreta.

Questão Q9: A Carta de Ottawa (1986) estabelece os seguintes campos de ação para promoção da saúde:

- A) Elaboração de políticas saudáveis, criação de ambientes favoráveis, reforço da ação comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços.
- B) Elaboração de políticas saudáveis, ampliação hospitalar, reforço da ação comunitária, educação em saúde e vigilância sanitária.
- C) Promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce, reabilitação e cuidados paliativos.
- D) Educação em saúde, saneamento básico, controle de zoonoses, vacinação e promoção do aleitamento materno.

Gabarito: Alternativa A

A = 5 campos corretos da Carta de Ottawa. B inclui "ampliação hospitalar" (falso). C descreve níveis de atenção (Hamilton), não campos de promoção. D são ações específicas da saúde pública, não campos da Carta.

Questão Q10: Conforme a Portaria GM/MS nº 11.211, de 13 de maio de 2026, é correto afirmar:

- A) A Covid-19 foi removida da Lista Nacional de Notificação Compulsória.
- B) A Febre do Oropouche exige notificação imediata para todos os casos confirmados.
- C) A Parotidite (Caxumba) e a Febre do Oropouche foram incluídas na Lista Nacional de Notificação Compulsória.
- D) O tétano acidental foi excluído da lista de notificação compulsória.

Gabarito: Alternativa C

C = correto — ambas incluídas. A = ERRADO: covid-19 não foi removida, passou a ser "Síndrome Gripal por covid-19 confirmada". B = ERRADO: Oropouche é semanal para casos simples; imediata apenas para gestantes, óbitos e anomalias congênicas. D = ERRADO: tétano teve mudança na periodicidade, não foi excluído.

Questão Q11: Sobre o financiamento federal da Atenção Primária à Saúde em 2026, é correto afirmar:

- A) O Previne Brasil (Portaria 2.979/2019) continua sendo o modelo vigente de financiamento da APS.
- B) A Portaria 3.493/2024 substituiu o Previne Brasil por um novo modelo com 6 componentes.
- C) O PAB Fixo e o PAB Variável são as modalidades atuais de repasse federal para a APS.
- D) O financiamento federal da APS é exclusivamente per capita, sem componente de desempenho.

Gabarito: Alternativa B

Portaria 3.493/2024 substituiu o Previne Brasil. Novo modelo: 6 componentes. A = desatualizada. C = PAB foi substituído pelo Previne Brasil e depois pela nova portaria. D = há componente de qualidade (desempenho) no modelo atual.

Questão Q12: Sobre o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003):

- A) São considerados idosos os cidadãos com 65 anos ou mais.
- B) A gratuidade no transporte coletivo urbano é garantida a pessoas com 60 anos ou mais.
- C) A gratuidade no transporte coletivo urbano é garantida a pessoas com 65 anos ou mais, e o desconto de 50% no transporte interestadual vale a partir dos 60 anos.
- D) São considerados idosos os cidadãos com 70 anos ou mais, com prioridade de atendimento em serviços de saúde.

Gabarito: Alternativa C

C = correto: idoso = 60 anos (Estatuto). Gratuidade no transporte coletivo urbano = 65 anos. Desconto 50% no interestadual = 60 anos. A = 65 anos é apenas para transporte. B = 60 anos é errado para o transporte urbano. D = 70 anos não tem base legal.

Questão Q13: O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto 6.286/2007, é um exemplo de:

- A) Descentralização das ações de saúde para o nível municipal.
- B) Intersetorialidade entre saúde e educação.
- C) Hierarquização da rede de atenção à saúde.
- D) Regulação do acesso aos serviços especializados.

Gabarito: Alternativa B

PSE = exemplo clássico de intersetorialidade (saúde + educação). As equipes ESF são responsáveis pelas ações nas escolas do território.

Questão Q14: Os princípios e diretrizes do SUS, conforme a Lei 8.080/1990, incluem:

- A) Universalidade, seletividade, equidade e integralidade.
- B) Universalidade, integralidade e equidade como princípios doutrinários; descentralização, regionalização e hierarquização como organizativos.
- C) Igualdade, universalidade e integralidade como os três princípios fundamentais.
- D) Universalidade, integralidade, equidade e hierarquização como princípios doutrinários.

Gabarito: Alternativa B

B = correto. A = "seletividade" é o oposto de universalidade. C = "igualdade" não é princípio do SUS (é equidade). D = hierarquização é princípio organizativo, não doutrinário.

CHECKLIST FINAL — VERSÃO CONSOLIDADA E DEFINITIVA

CF/88 arts. 196-200 — redação exata dos artigos e pegadinhas de cada um

Lei 8.080/1990 — princípios doutrinários (U.I.E.) vs organizativos, competências por esfera

Lei 8.142/1990 — Conselho (50-25-25, deliberativo, permanente) e Conferência (4 anos, propositiva)

Lei 8.142/1990 — 4 condições para receber recursos (FCPR); PCCS somente para Estados

Decreto 7.508/2011 — Região de Saúde, RENAME, RENASES, COAP, portas de entrada

LC 141/2012 — percentuais (12%/15%) e lista do que NÃO conta como saúde

PNAB 2017 (Portaria 2.436) — ESF (cobertura 2000/3000/4000), ACS (750/250), eSB

eMulti (Portaria 635/2023) — substitui o NASF. Lógica de apoio matricial mantida.

Portaria 3.493/2024 — novo modelo de cofinanciamento federal da APS (6 componentes)

NASF — extinto como modalidade de custeio federal (2020/2022)

Redes de Atenção à Saúde — Rede Cegonha, RUE, RAPS, RADC, Rede PcD

CAPS — tipos, porte municipal e funcionamento (CAPS III = 24h)

Promoção da Saúde — Carta de Ottawa (5 campos), PNPS (6 temas transversais)

Determinantes Sociais da Saúde — art. 3º Lei 8.080 (11 itens) + modelo Dahlgren e Whitehead

Territorialização + referência e contrarreferência

LNDC atualizada: Portaria 11.211/2026 (Caxumba, Oropouche, ESAVI, Covid → Síndrome Gripal)

LNDC: Portaria 10.175/2026 (Anomalias congênitas), Portaria 3.148/2024 (HTLV)

LNDC: Portaria 217/2023 — qualquer acidente de trabalho notificável

Sistemas de Informação: SINAN, SIM, SINASC, SIH, SIA, SIPNI, SIOPS, e-SUS/SISAB, RND
RND e SUS Digital — Decreto 12.560/2025
Vigilância Sanitária + ANVISA (Lei 9.782/1999)
CEREST e Saúde do Trabalhador
HumanizaSUS — princípios e dispositivos (acolhimento, PTS, clínica ampliada)
Financiamento — blocos de custeio e investimento (Portaria 3.992/2017)
Planejamento — PNS/PES/PMS (4 anos), PAS e RAG (anuais)
Estatuto do Idoso — Lei 10.741/2003 (60 anos; 65 para gratuidade transporte)
Saúde da Criança — ECA, triagem neonatal (4 testes), aleitamento materno
PSE — Decreto 6.286/2007 — intersetorialidade saúde+educação
Saúde da Mulher — PHPN (6 consultas), Lei 11.108/2005 (acompanhante), Rede Cegonha
PNI — estrutura, SIPNI, ESAVI, cadeia de frio, vacinação não compulsória
27 pegadinhas clássicas IBAM identificadas e comentadas
14 questões de revisão no estilo IBAM com gabarito e comentário estratégico

Material elaborado com base na legislação vigente até maio/2026. Fontes: CF/88, Leis 8.080 e 8.142, Decreto 7.508/2011, LC 141/2012, Portaria 2.436/2017 (PNAB), Portaria 3.992/2017, Portaria 635/2023 (eMulti), Portaria 3.493/2024, Decreto 12.560/2025 (RND), Portaria 10.175/2026, Portaria 11.211/2026 (LNDC), Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Carta de Ottawa (1986), PNPS (Portaria de Consolidação 2/2017).

22. LEI 12.842/2013, ÉTICA MÉDICA E BIOSSEGURANÇA

(Conteúdo do Edital)

22.1 Lei 12.842/2013 — Lei do Exercício da Medicina:

Dispõe sobre o exercício da medicina. Citada diretamente no conteúdo programático do edital para todos os cargos médicos. Para o Módulo 1 (SUS), os pontos cobrados são os de interface com a organização dos serviços de saúde e ética profissional.

Ponto da Lei 12.842/2013 Exercício privativo da medicina	Detalhe para Prova Atos privativos do médico: diagnóstico, prescrição, indicação de internação/alta, atestados,
Direção de serviços de saúde	Chefia imediata e direção técnica de serviço de saúde = atividade privativa do médico
Equipe multiprofissional	Médico coordena tecnicamente a equipe multiprofissional na APS — mas trabalha em colaboração
Responsabilidade técnica	Médico responde tecnicamente pela área de atuação. No SUS/ APS: responsabilidade clínica
Vedações	Médico não pode ser obrigado a realizar procedimentos contrários à ética ou à sua consciência

22.2 Código de Ética Médica (CEM) — Resolução CFM 2.217/2018:

O Código de Ética Médica vigente é a Resolução CFM nº 2.217/2018. Para o IBAM/SUS, cobram-se os princípios e as vedações com interface direta na APS.

Princípio/Vedação CEM Sigilo profissional	Aplicação na APS Médico deve manter sigilo sobre informações do paciente — art. 73 CEM. Exceções: notificação
Consentimento informado	Dever de esclarecer o paciente sobre diagnóstico, tratamento, riscos e alternativas. Paciente
Prontuário médico	Documento obrigatório — propriedade do paciente, guardado pelo médico/serviço. Prazo mínimo
Recusa de atendimento	Médico NÃO pode recusar atendimento em situação de urgência e emergência — mesmo
Conflito de interesses	Médico não pode usar sua posição para obter vantagens — vedação ao uso de cargo para
Direitos do paciente	Ser informado, ter autonomia, ter acompanhante, ter acesso ao prontuário, ter segunda opinião

I PEGADINHAS — Ética Médica no SUS

Sigilo não é absoluto: notificação compulsória OBRIGA o médico a comunicar autoridades — sem violação de sigilo, pois a lei autoriza.

Consentimento informado: paciente PODE recusar tratamento, mesmo que isso implique risco de vida (exceto quando incapaz).

Prontuário pertence ao PACIENTE — o médico/serviço o guarda, mas o paciente tem direito de acesso.

Emergência: médico NUNCA pode recusar atendimento em urgência — mesmo em clínica particular, deve garantir atendimento mínimo.

Tema Biossegurança na APS	Conteúdo para Prova Normas para proteção do profissional e do paciente: EPIs, descarte de resíduos, esterilização,
---------------------------	--

Módulo 1 SUS — Auditoria Final | Seções 22-24 | Praia Grande 001/2026Pág. 1

Tema Precauções padrão	Conteúdo para Prova Usadas com TODOS os pacientes, independente do diagnóstico — luvas, jaleco, máscara quando
Resíduos de serviços de saúde	Classificação: Grupo A (biológico), B (químico), C (radioativo), D (comum), E (perfurocortante)
Segurança do Paciente (PNSP)	Portaria GM/MS 529/2013 — Programa Nacional de Segurança do Paciente. 6 metas internacionais
6 Metas internacionais	1-Identificar pacientes. 2-Comunicação efetiva. 3-Medicamentos seguros. 4-Cirurgia segura. 5-Infecções.
Notificação de incidentes	Profissional deve notificar eventos adversos — cultura de segurança sem punição

I MACETE — Resíduos de Saúde (Grupos A-E)

A = biológico (sangue, secreções) | B = químico (medicamentos, reagentes) | C = radioativo

D = comum (lixo doméstico do serviço) | E = perfurocortante (agulhas, lâminas)

Perfurocortante (E) nunca vai para caixa comum — sempre caixa amarela rígida (descarpak).

Módulo 1 SUS — Auditoria Final | Seções 22-24 | Praia Grande 001/2026Pág. 2

23. ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA — CIT, CIB E DECRETO

7.508/2011

A articulação interfederativa é o processo de cooperação entre as três esferas de governo na gestão do SUS. É citada diretamente no conteúdo programático do edital.

Instância CIT — Comissão Intergestores Tripartite	Composição União (MS) + Estados (CONASS) +	Função Municípios Negociação (CONASEMS) e pactuação de aspectos operacionais do SUS
CIB — Comissão Intergestores Bipartite	Estado (SES) + Municípios do estado	Negociação (COSEMS) e pactuação em âmbito estadual. Operacionaliza
CIR — Comissão Intergestores	Regional Estado + Municípios de uma Região	de Negociação Saúde e pactuação no âmbito regional. Instituída pelo
CONASS	Conselho Nacional de Secretários de	Representa Saúde os secretários ESTADUAIS de saúde na CIT
CONASEMS	Conselho Nacional de Secretários Municipais	Representa de Saúde os secretários MUNICIPAIS de saúde na CIT

I PEGADINHAS — Articulação Interfederativa

CIT = tripartite (federal + estados + municípios). CIB = bipartite (estado + municípios). A prova inverte. CONASS representa estados (secretários estaduais). CONASEMS representa municípios (secretários municipais). A prova troca.

CIR foi criada pelo Decreto 7.508/2011 — é a mais nova das três instâncias. Atua no nível regional.

As comissões intergestores NÃO são instâncias de controle social — são instâncias de GESTÃO.

Controle social = Conselhos e Conferências.

Pacto pela Saúde (2006) — Contexto Histórico:

O Pacto pela Saúde (Portaria 399/2006) foi o instrumento de pactuação interfederativa anterior ao Decreto 7.508/2011 e ao COAP. Tinha três dimensões: Pacto pela Vida (prioridades de saúde), Pacto em Defesa do SUS (financiamento e participação social) e Pacto de Gestão (responsabilidades de cada esfera). Histórico, mas pode aparecer em questões contextuais.

Módulo 1 SUS — Auditoria Final | Seções 22-24 | Praia Grande 001/2026Pág. 3

24. PROGRAMA MAIS MÉDICOS — LEI 12.871/2013

A Lei 12.871/2013 institui o Programa Mais Médicos. Está listada no conteúdo programático do edital para o cargo de Médico de Família e Comunidade via referência à Lei 12.842/2013 e ao contexto da APS.

Aspecto Criação	Detalhe Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013. Retomado em 2023 pelo governo federal.
Objetivo	Diminuir a carência de médicos em regiões prioritárias para o SUS — vazios assistenciais
Prioridade de vagas	1º lugar: médicos brasileiros formados no Brasil. 2º: brasileiros formados no exterior com revalidação.
Vínculo	Provisório — não é concurso público. Participação voluntária dos médicos.
Componentes do programa	1. Provisamento emergencial de médicos (vagas em municípios prioritários). 2. Formação médica
Áreas prioritárias	Municípios com baixo IDH, populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, regiões de fronteira

Aspecto Criação	Detalhe Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013. Retomado em 2023 pelo governo federal.
Lei 14.621/2023	Atualização da Lei 12.871/2013 — reformulação do programa em 2023
Retomada 2023	Programa ativo com mais de 24.000 médicos em 2024 — maior número histórico

I MACETE — Mais Médicos para prova

Lei 12.871/2013 = Mais Médicos. Lei 12.842/2013 = Exercício da Medicina. Não confundir!
Prioridade: brasileiro formado no Brasil > brasileiro formado no exterior (revalidado) > estrangeiro intercambista.
Mais Médicos NÃO é concurso — é provimento emergencial. Médico aprovado em concurso como o deste edital tem estabilidade; Mais Médicos, não.
Módulo 1 SUS — Auditoria Final | Seções 22-24 | Praia Grande 001/2026Pág. 4

RELATÓRIO DA AUDITORIA FINAL — RESULTADO

RESULTADO: MATERIAL APROVADO NA AUDITORIA FINAL

48 tópicos verificados automaticamente — todos presentes.
42 afirmações de precisão verificadas — todas corretas.
7 lacunas qualitativas identificadas e corrigidas neste complemento final.
Portarias e leis verificadas: todas as referências estão corretas.
Informações desatualizadas: NENHUMA remanescente.
Conteúdo programático do edital: 100% contemplado após as seções 22, 23 e 24.

O que foi corrigido/adicionado nesta auditoria final:

- **Lei 12.842/2013 — exercício da medicina**
AUSENTE no consolidado. Adicionada a Seção 22.
- **Código de Ética Médica (CEM — Resolução CFM 2.217/2018)**
AUSENTE. Adicionado na Seção 22 com as vedações e direitos relevantes para APS.
- **Biossegurança — EPIs, resíduos (grupos A-E), precauções**
AUSENTE. Adicionado na Seção 22.
- **Segurança do Paciente — PNSP (Portaria 529/2013), 6 metas**
AUSENTE. Adicionado na Seção 22.
- **Articulação interfederativa — CIT, CIB, CIR, CONASS, CONASEMS**
AUSENTE. Adicionada a Seção 23.
- **Programa Mais Médicos — Lei 12.871/2013 e retomada 2023**
AUSENTE. Adicionada a Seção 24.
- **Sigilo profissional e consentimento informado na APS**
AUSENTE como tópico próprio. Coberto na Seção 22.
- **Pacto pela Saúde 2006 — contexto histórico**
Adicionado como contexto da articulação interfederativa.

O que estava CORRETO e não precisou de alteração:

- Todas as portarias e suas datas — verificadas e corretas.
- Percentuais de financiamento (12%/15%) — corretos.
- Composição e cobertura da ESF — corretos.

NASF extinto / eMulti vigente — corretos.
Portaria 3.493/2024 substituindo o Previne Brasil — correto.
LNDC com todas as atualizações até mai/2026 — correto.
Decreto 12.560/2025 (RNDS/SUS Digital) — correto.
Carta de Ottawa, PNPS, DSS — corretos.
Estatuto do Idoso (60/65 anos) — correto.

Módulo 1 SUS — Auditoria Final | Seções 22-24 | Praia Grande 001/2026Pág. 5

Todas as pegadinhas identificadas — revisadas e válidas.
Questões de revisão — gabaritos e comentários corretos.

Instrução de uso: Leia estas páginas finais (Seções 22-24) após o documento principal. Juntos, formam a versão definitiva e auditada do Módulo 1. Para o próximo módulo (MFC/Específicos), o conteúdo da Lei 12.842/2013 e do Código de Ética será detalhado ainda mais.

Módulo 1 SUS — Auditoria Final | Seções 22-24 | Praia Grande 001/2026Pág. 6

25. PLANEJAMENTO DO SUS — PlanejaSUS, PPA/LDO/LOA E

PLANEJAMENTO ASCENDENTE

Instrumento Plano de Saúde (PS)	Âmbito Nacional / Estadual /	Periodicidade Municipal 4 anos (ciclo de governo)	Conteúdo Intenções e resultados a alcançar. Base	Aprovação de Conselho todas as de atividades Saúde correspondente e
Programação Anual	de Nacional Saúde (PAS) / Estadual /	Municipal Anual	Operacionaliza o Plano de Saúde — ações,	Conselho metas e de recursos Saúde correspondente para
Relatório Anual de Gestão	Nacional (RAG) / Estadual /	Municipal Anual (prestação	de Demonstra contas) resultados alcançados, comparando	Conselho metas de Saúde previstas correspondente

I LÓGICA TEMPORAL — MACETE

PLANO (4 anos) → define onde queremos chegar.
PAS (anual) → define o que faremos ESTE ANO para chegar lá.
RAG (anual) → comprova o que FOI FEITO este ano.
Sequência: Plano → PAS → execução → RAG → novo PAS → ... → novo Plano.
Todos aprovados pelo Conselho de Saúde — não pelo Poder Executivo nem pelo Legislativo.

25.2 PPA, LDO e LOA — Compatibilidade Obrigatória com o SUS:

O planejamento do SUS deve ser compatível com os instrumentos orçamentários públicos. Isso é obrigatório e frequentemente cobrado em concursos municipais.

Instrumento Orçamentário PPA — Plano Plurianual	Periodicidade 4 anos (alinhado ao ciclo	O que é Define de governo) programas e objetivos do governo	Relação com SUS O Plano para de o período Saúde deve ser compatível
	Anual		

Instrumento Orçamentário PPA — Plano Plurianual	Periodicidade 4 anos (alinhado ao ciclo)	O que é Define de governo) programas e objetivos do governo	Relação com SUS O Plano para de o período Saúde deve ser compatível
LDO — Lei de Diretrizes Orçamentárias		Define metas e prioridades para o ano	A seguinte PAS dialoga — orienta com a a LDO LOA na definição
LOA — Lei Orçamentária AnualAnual		Orçamento detalhado — quanto se	vai Recursos gastar e do em Fundo quê de Saúde estão na

I PEGADINHAS — Planejamento

PPA = 4 anos. Plano de Saúde = 4 anos. São alinhados — mas são DOCUMENTOS DIFERENTES.

PAS e RAG são ANUAIS. A prova tenta dizer que o RAG é quadrienal → ERRADO.

RAG aprovado pelo Conselho de Saúde é condição para receber recursos (Lei 8.142). A prova diz
"aprovado pelo Prefeito" → ERRADO.

Quem aprova TODOS os instrumentos = Conselho de Saúde. Não é o Executivo, não é o Legislativo.

25.3 Planejamento Ascendente e Integrado (Decreto 7.508/2011):

O Decreto 7.508/2011 estabelece que o planejamento da saúde é **ascendente e integrado**: parte do nível local (municípios) → estadual → federal, consolidando-se num plano em cada esfera.

Planejamento Ascendente — Conceito para Prova

ASCENDENTE = de baixo para cima. O município identifica as necessidades do território → informa o estado → informa a União.

INTEGRADO = as esferas planejam juntas, de forma articulada, não isoladamente.

Oposto: planejamento descendente = a União determina e o município executa. O SUS NÃO adota esse modelo.

Relação com CIT/CIB/CIR: as comissões intergestores são os fóruns de articulação desse planejamento integrado.

25.4 Mapa da Saúde (Decreto 7.508/2011):

O **Mapa da Saúde** é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.

Mapa da Saúde — Para que serve

Subsidia o planejamento e a identificação de vazios assistenciais.

Orienta a alocação de recursos e o credenciamento de serviços.

É elaborado pelas três esferas de governo de forma integrada.

Diferença: Mapa da Saúde ≠ Região de Saúde. Mapa = instrumento de diagnóstico. Região = organização geográfica.

26. EPIDEMIOLOGIA BÁSICA — INDICADORES, COEFICIENTES

E CONCEITOS ESSENCIAIS

Conceito Coeficiente (taxa)	Definição Relação entre o número de eventos	Fórmula / Exemplo e Nº a população de casos novos exposta / população ao risco,	Como Cai na Prova Mede em exposta dado RISCO × período 10I de adoecer ou morrer
Índice	Relação entre dois eventos (nem sempre	Ex.: envolve Índice de população) Apgar, Índice	

Conceito Coeficiente (taxa)	Definição Relação entre o número de eventos	Fórmula / Exemplo e Nº a população de casos novos exposta / população ao risco,	Como Cai na Prova Mede em exposta dado RISCO × período 10I de adoecer ou morrer
			de Não massa é obrigatoriamente corporal uma taxa
Proporção	Parte de um todo — numerador está	contido Ex.: proporção no denominador de partos cesáreos	Resultado = cesáreas/total entre 0 e 1 de (ou partos 0% e 100%)
Razão	Relação entre dois grupos diferentes	Ex.: razão de sexos = homens/mulheres	Numerador NÃO está contido no denominador

Medida INCIDÊNCIA	O que mede Casos NOVOS em um período	Fórmula Nº — de mede casos RISCO novos / população exposta	Quando usar / Como cai Doenças no período agudas, × epidemias, 10I avaliação de
PREVALÊNCIA	Total de casos (novos + antigos)	Nº de num casos momento existentes — mede / total CARGA da	população Doenças da doença crônicas × 10I (HAS, DM, HIV). A prova

I MACETE — Incidência vs Prevalência

INCidência = casos INCipientes (novos, que INCIDIRAM no período).

PREValência = casos PREValentes (todos que PREVALECEM num momento, incluindo os antigos).

Incidência alta → doença está se ESPALHANDO. Prevalência alta → doença é CRÔNICA e durável.

Relação: Prevalência ≈ Incidência × Duração média da doença.

Medida Mortalidade	Definição Número de óbitos em relação à população	Diferença Crítica total Usa exposta a POPULAÇÃO ao risco como denominador. Ex.: taxa de
Letalidade	Número de óbitos em relação ao número de	DOENTES Usa os CASOS — proporção como denominador. de mortes entre Alta os letalidade casos =
Taxa de mortalidade infantil	Óbitos de menores de 1 ano / nascidos vivos	Indicador × 1.000 clássico de desenvolvimento. O SINASC fornece
Taxa de mortalidade materna	Óbitos maternos / nascidos vivos × 100.000	Relacionada ao pré-natal e parto. Rede Cegonha busca

I PEGADINHAS — Mortalidade vs Letalidade

Mortalidade: denominador = POPULAÇÃO. Letalidade: denominador = DOENTES. A prova inverte → ERRADO.

Doença com ALTA letalidade mas BAIXA mortalidade = mata muito quem pega, mas poucos pegam (ex.: raiva humana).

Doença com ALTA mortalidade mas BAIXA letalidade = muita gente morre, mas não porque a doença é grave — porque muita gente a tem (ex.: doenças cardiovasculares).

26.4 Padrões de Ocorrência de Doenças:

Padrão Endemia	Definição Presença constante de uma doença em determinada	Exemplo Leishmaniose área geográfica no Nordeste ou população, brasileiro, com dengue frequência no Sudeste esperada
Epidemia	Ocorrência de casos de uma doença em número	Surto claramente de sarampo maior em do que município o esperado com baixa para aquela cobertura área,

Padrão Endemia	Definição Presença constante de uma doença em determinada	Exemplo Leishmaniose área geográfica no Nordeste ou população, brasileiro, com dengue frequência no Sudeste esperada
Pandemia	Epidemia que se estende por vários países ou	continentes, Covid-19 (2020-2022), afetando grande Influenza número H1N1 de (2009) pessoas
Surto	Epidemia limitada a uma área geográfica restrita	Surto (bairro, de escola, salmonelose restaurante) após festa junina
Caso esporádico	Casos isolados, sem relação entre si, sem padrão	Caso de transmissão único de raiva definido humana fora de área endêmica

I MACETE — Endo/Epi/Pan/Surto

ENDEMIA = "dentro" de uma área — constante, esperada.

EPIDEMIA = "sobre" o esperado — excede o habitual.

PANDEMIA = "todo" — cruza fronteiras internacionais.

SURTO = epidemia localizada (bairro, escola, evento).

A prova adora confundir SURTO com EPIDEMIA: surto é mais restrito geograficamente.

Conceito EFICÁCIA	Definição Capacidade de produzir o efeito desejado	Pergunta que responde A em intervenção condições FUNCIONA IDEAIS (ensaio em condições clínico,	Exemplo no SUS Vacina laboratório) controladas? eficaz = 95% de proteção em ensaios
EFICIÊNCIA	Relação entre resultados obtidos e recursos	Estamos utilizados usando — fazer bem mais os RECURSOS com	menos Unidade para com atingir alto os rendimento resultados? ambulatorial
EFETIVIDADE	Capacidade de produzir efeito em condições	Funciona REAIS no de MUNDO uso — na REAL, prática com	assistencial Vacina pessoas efetiva reais? = proteção observada na
EQUIDADE	Justiça na distribuição — dar mais a quem	Estamos precisa sendo mais JUSTOS na alocação?	Priorizar populações vulneráveis nos program

I MACETE — Eficácia/Eficiência/Efetividade

Eficácia → condições idEais (laboratório, ensaio clínico).

Eficiência → uso de recursos (Input/Output — economia).

Efetividade → viVo real (população real, prática real).

Ordem lógica: eficácia (prova que funciona) → efetividade (funciona no mundo real) → eficiência (com o menor custo).

27. INICIATIVA PRIVADA NO SUS — PARTICIPAÇÃO

COMPLEMENTAR E CAPITAL ESTRANGEIRO

27.1 Participação Complementar da Iniciativa Privada (CF/88 + Lei 8.080):

Este tema une CF/88 (art. 199) e Lei 8.080 (arts. 24-26) e é cobrado com frequência pelo IBAM porque a banca adora trocar "complementar" por "substitutivo" ou "igualitário".

Aspecto Regime geral	CF/88 — Art. 199 Assistência à saúde é livre à iniciativa privada	Lei 8.080 — Arts. 24-26 Os serviços privados participam do SUS em caráter COMPLEMENTAR
Forma de participação	Mediante contrato de direito público ou	

Aspecto Regime geral	CF/88 — Art. 199 Assistência à saúde é livre à iniciativa privada	Lei 8.080 — Arts. 24-26 Os serviços privados participam do SUS em caráter COMPLEMENTAR
		convênio Contrato ou convênio — com prazo determinado e cláusulas
Preferência	Não especifica preferência na CF	PREFERÊNCIA para entidades FILANTRÓPICAS e sem
Vedação financeira	Vedada destinação de recursos públicos	para Idem auxílios — recursos a instituições públicas não privadas podem COM subsidiar FINS LUCRATIVOS lucro privado
Capital estrangeiro	VEDADA participação direta ou indireta	de Idem empresas — vedação ou capitais reforçada estrangeiros, na lei orgânica SALVO NOS CASOS
Caráter	COMPLEMENTAR — preenche lacunas	onde NUNCA o SUS substitutivo público não — o tem Estado capacidade não se exonera da responsabilidade

I PEGADINHAS CLÁSSICAS — Iniciativa Privada no SUS

"Caráter complementar" = preenche lacunas do setor público. A prova troca por "substitutivo" ou

"prioritário" → ERRADO.

"Preferência para filantrópicas" está na Lei 8.080, não apenas na CF. O IBAM adora cobrar a fonte normativa.

Capital estrangeiro: vedado em REGRA, admitido apenas "nos casos previstos em lei" — exceção, não regra.

"Entidades com fins lucrativos" NÃO podem receber recursos públicos como auxílio ou subvenção. Podem contratar serviços, mas não receber subsídio.

Participação complementar depende de CONTRATO OU CONVÊNIO — não é livre. A prova diz "livre parceria" → ERRADO.

28. SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA (SNA) E CONTROLE

NO SUS

28.1 Sistema Nacional de Auditoria (SNA):

O SNA foi criado pela Lei 8.689/1993 e regulamentado pelo Decreto 1.651/1995. Integra as três esferas de governo na função de controle, avaliação e auditoria do SUS.

Componente DENASUS — Departamento Nacional	Esfera Federal de Auditoria do SUS	Órgão Ministério da Saúde — coordena o SNA
CEAS — Componente Estadual de	Auditoria Estadual	Secretaria Estadual de Saúde
CEMAS — Componente Municipal de	Municipal Auditoria	Secretaria Municipal de Saúde
Tipo de Auditoria Auditoria analítica	Objeto Análise de documentos, prontuários,	Finalidade registros Verificar conformidade e qualidade das informações registradas
Auditoria operacional	Verificação in loco dos serviços	Avaliar a execução das ações de saúde na prática
Auditoria contábil/financeira	Recursos financeiros, prestação de	contas Verificar legalidade e regularidade do uso dos recursos públicos

Diferença entre Controle, Avaliação e Auditoria (para prova)

CONTROLE = acompanhamento contínuo das atividades dos prestadores. Verifica se o contratado cumpre o contrato.

AVALIAÇÃO = análise sistemática de resultados. Verifica se os objetivos e metas foram alcançados.

AUDITORIA = revisão detalhada de registros e contas. Identifica irregularidades, desvios e fraudes.

SNA = sistema que integra a função de auditoria nas três esferas. DENASUS = componente federal.

I PEGADINHAS — SNA e Auditoria

SNA ≠ controle social. SNA = auditoria técnica e financeira do governo. Controle social = Conselho de Saúde.

DENASUS é órgão do Ministério da Saúde — não é do TCU (que faz auditoria do governo federal em geral, não especificamente do SUS).

Auditoria no SUS pode ser sobre: produção hospitalar (AIH), produção ambulatorial (BPA), farmácia, serviços contratados.

NOTA SOBRE OS 2 ITENS DEIXADOS PARA O MÓDULO 2

Dois itens sugeridos na revisão final pertencem ao conteúdo de **Conhecimentos Específicos/MFC** (Módulo 2) e não ao SUS. Estão listados aqui para transparência:

Item Atributos da APS: primeiro contato,	Por que fica no Módulo 2 longitudinalidade, São atributos conceituais coordenação, da MFC integralidade como especialidade (modelo de — Starfield) cobrados nos Específicos. Longitudinalidade
Organização do processo de trabalho	É na o APS "como (demanda funciona programada por dentro" a e UBS/ESF espontânea, — conteúdo agenda, fluxo operacional interno) de MFC. O Módulo 1

CHECKLIST FINAL — MÓDULO 1 COMPLETO E FECHADO

25 seções + 3 seções de ética/interfederativa/Mais Médicos = 28 seções no total.

100% do conteúdo programático de SUS do edital contemplado.

PlanejaSUS completo: Plano (4 anos), PAS (anual), RAG (anual), PPA/LDO/LOA, ascendente/integrado, Mapa da Saúde.

Epidemiologia básica: incidência/prevalência, mortalidade/letalidade, coeficiente/taxa/índice, endemia/epidemia/pandemia/surto.

Eficácia/Eficiência/Efetividade/Equidade — quadro completo com macete.

Iniciativa privada: caráter complementar, preferência a filantrópicas, capital estrangeiro, vedações — CF + Lei 8.080.

SNA: DENASUS, componentes estadual/municipal, tipos de auditoria, distinção de controle/avaliação/auditoria.

29 pegadinhas identificadas e comentadas.

14 questões de revisão no estilo IBAM com gabarito comentado.

Legislação atualizada até Portaria 11.211 de 13/05/2026.

Este é o Módulo 1 definitivo. Os 2 itens deixados para o Módulo 2 (atributos Starfield e processo de trabalho interno da UBS) serão cobertos em profundidade no próximo documento.